



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN KINERJA TAHUNAN KOMITE MEDIK TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**LAPORAN KINERJA UNIT KOMITE MEDIK
RS PRIMA HUSADA MALANG TAHUN 2025**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Umum / Latar Belakang

Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medik dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medik, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medik.

Untuk menjamin agar komite medik berfungsi dengan baik, organisasi dan tata laksana komite medik dituangkan dalam peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*) yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755 / Menkes / Per / IV / 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit. Pada prinsipnya peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*) merupakan dasar normatif bagi setiap staf medis agar tercipta budaya profesi yang baik dan akuntabel.

Program kerja komite medik RS Prima Husada adalah program untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medik di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medik, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medik. Sedangkan staf medik adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Untuk menjamin agar program komite medik RS Prima Husada berfungsi dengan baik, maka program kegiatan yang disusun harus berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut Komite Medik berkewajiban membuat program kegiatan dalam setiap tahunnya. Program kegiatan Komite Medik ini merupakan program kegiatan yang berasal dari program kegiatan yang disusun oleh masing-masing Sub Komite Medik, sehingga akan didapat program kegiatan yang terencana, terarah dan berkesinambungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan medikoleh masing-masing Sub Komite Medik. Program kegiatan ini selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap program kegiatan dan tindak lanjut dari hasil evaluasi program yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian akan tercapai peningkatan mutu pelayanan medik sesuai yang diharapkan.



1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Tujuan Umum

Untuk memberikan gambaran kepada seluruh staf medik, tentang program-program kegiatan komite medik yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medik di RS Prima Husada.

b. Tujuan Khusus

Untuk meningkatkan mutu pelayanan medik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sehingga dapat memberikan kepuasan pada pasien maupun pemakai jasa di RS Prima Husada.

BAB II. GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi : “ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberi pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Motto

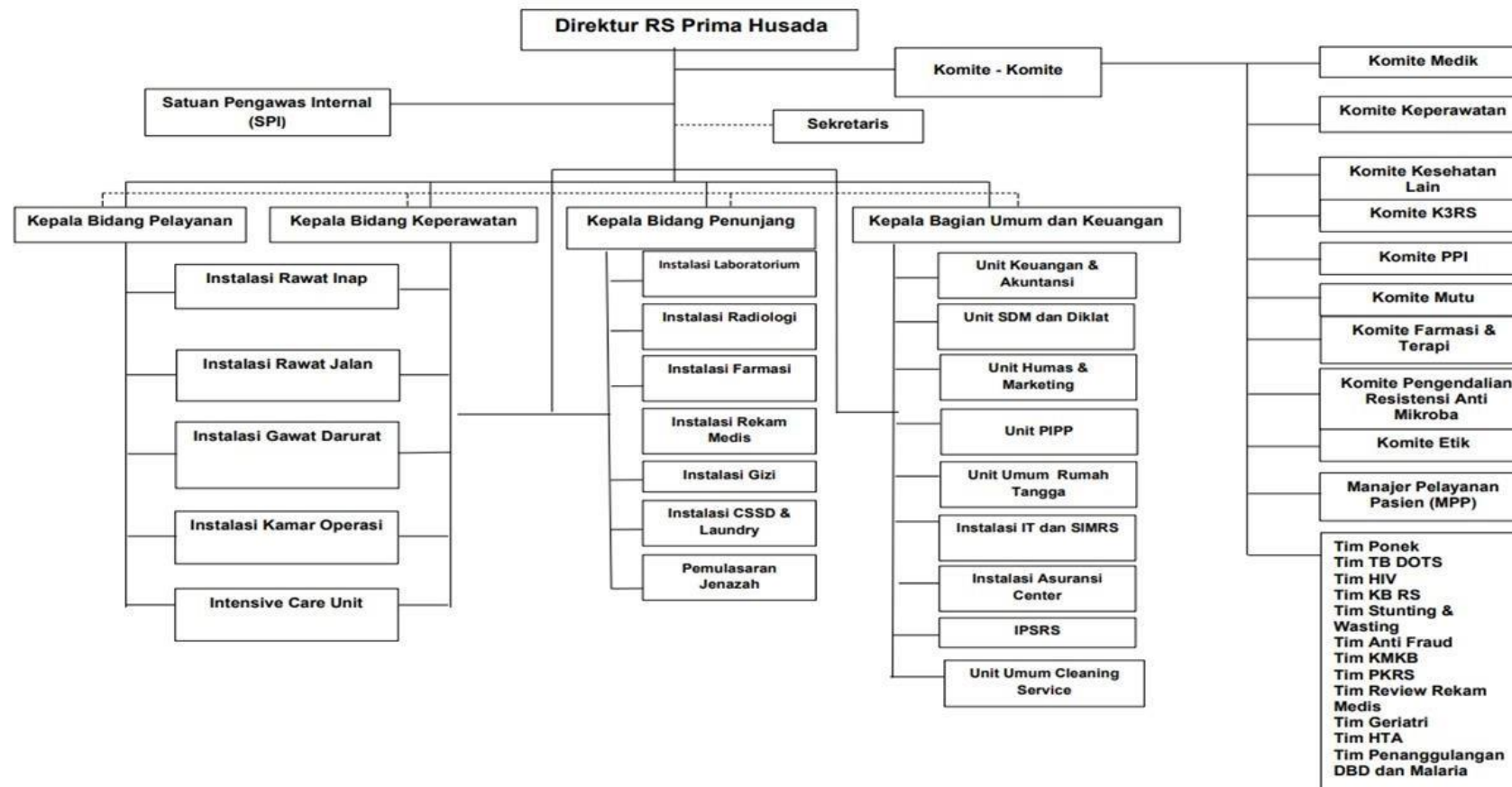
Motto RS Prima Husada : “Sahabat Menuju Sehat”

2.4 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK





RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MEDIK

Ketua Komite Medik
dr. Arief Heru Wicaksono, SpAn

Sekretaris
Fadhila Ayu Setyani, S.Kep.Ns

Sub Komite Kredensial

Ketua : dr. Dewi Maharani, SpS
Anggota : dr. Dicky Faturrachman, SpA

Sub Komite Mutu Profesi

Ketua : dr. Ira S, SpJP
Anggota : dr. Miryanti C, SpJP

Sub Etik dan Disiplin Profesi

Ketua : dr. Ari Putriani, SpPK
Anggota : dr. Humaira, SpOG

BAB III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 SDM
3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Jabatan	Jumlah SDM													Ket.	
	Analisis Beban Kerja	Bulan Ke-												Kebutuhan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ketua Komite Medik	ABK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Lampiran A
Sekretaris Komite Medik	ABK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Lampiran A
Ketua Sub Komite Kredensial	ABK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Lampiran A
Anggota Sub Komite Kredensial	ABK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Lampiran A
Ketua Sub Komite Mutu Profesi	ABK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Lampiran A
Anggota Sub Komite Mutu Profesi	ABK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Lampiran A
Ketua Sub Komite Etik & Disiplin	ABK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Lampiran A
Anggota Sub Komite Etik & Disiplin	ABK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Lampiran A
Anggota	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	Lampiran A
Total		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	0	Lampiran A

Dari tabel diatas tampak bahwa ketenagaan komite medik sudah sesuai standart, anggota terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis RS Prima Husada Malang.

RTL :
Untuk pengurus komite medik tidak ada perubahan, tetap menggunakan SK Pengurus Komdik Tahun 2025

3.1.2 Orientasi
Pada tahun 2025 terdapat orientasi 1 dokter gigi spesialis konservasi.

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Pelatihan /Workshop /Seminar / Inhouse Training
Tabel 3.1.3. 1.Hasil Kinerja Peningkatan SDM Komite Medik selama Tahun 2025

1. Pelatihan /Workshop /Seminar / Inhouse Training

NO	JENIS DIKLAT/WS/SEM/WB	JUMLAH PESERTA		TGL Pelaksanaan	Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari
		Hadir	Tidak Hadir		



3.1.4 Evaluasi Kinerja Staf

Evaluasi kinerja staf komite medik dinilai menggunakan OPPE 1 tahun sekali, raport anggota komite medik juga dilakukan untuk pertimbangan perpanjangan SIP. SIP saat ini sudah aktif.

3.2 Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Standart	Target	Hasil	K E T
1	Kedisiplinan pengurusan SIP dokter	1. Pendataan SIP yang akan habis 2. Follow up pengurusan	100%	Belum memenuhi target 100%, karena ada 5 dokter yang habis masa SIP nya	1. Mendata SIP DPJP yang akan habis pada tahun 2025 2. Melakukan follow up pengurusan STR 3. Koordinasi dengan SDM terkait kelengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk pengurusan SIP 4. Membantu membuatkan surat keterangan jumlah pasien/Tindaka n untuk pengurusan STR	
2	Pelaksanaan E- RM	1. Sosialisasi E- RM pada dokter spesialis 2. Koordinasi dengan programmer 3. Membuat fitur aplikasi E-RM 4. Melakukan trial secara bertahap 5. Melakukan monitoring dan eksekusi apabila ada kendala 6. Melengkapi sarana	100%	Belum memenuhi target 100%, karena rehab medik belum full E-RM	1. Yang sudah melaksanakan E-RM adalah semua dokter. Termasuk poli rehab medik 2. Ada beberapa pasien yang di review oleh RM< hasilnya masih ada yang belum connect antara billing IRJA dengan RMdibutuhkan seperti PC, tab , specimen dll	



		prasarana yang				
3	Kredensial dokter baru	1. Menyiapkan berkas kelengkapan kredensial termasuk draft RKK 2. Mengajukan pada ketua komdik untuk dilakukan kredensial sesuai instruksi direktur 3. Pengisian draft RKK diserahkan bisa softcopy maupun hardcopy 4. Sekomdik mengajukan draft RKK ke Sub Kredensial dan disetujui oleh Ketua Komite Medik 5. Direktur menerbitkan surat penugasan klinis jika RKK sudah ditandatangani oleh sub kredensial dan ketua komdik	100%	Terpenuhi	Dokter yang melakukan proses kredensial tahun 2025 : 1. Drg. Khadijah Sp.KG	
4	Proporsi	Kebijakan PT terkait tarif proporsi dilakukan per September 2025	100%	Sudah memenuhi target	1. Rapat dan diskusi dilakukan oleh PT untuk kedua RS, RPHM dan RSPHS 2. Tarif proporsi dikenakan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap 3. Jika ada pasien yang melebihi	



					plafon inacbg's maka DPJP akan dikenakan tarif proporsi, sedangkan jika DPJP melakukan perawatan pada pasien dibawah inacbgs, maka akan surplus 4. Karena banyak DPJP yang tidak puas dengan adanya tarif proporsi, diadakan rapat diskusi baik offline door to door maupun zoom yang dilakukan untuk menjembatani agar kebijakan proporsi dapat diterima dengan bijak 5. Perubahan tarif obat, tindakan maupun ruangan di review ulang oleh PT 6. Diharapkan DPJP dapat bekerjasama dan koordinasi terkait kendala dan solusi dari kebijakan proporsi, agar kebijakan tersebut tetap safety di dpjp maupun pasien	
--	--	--	--	--	--	--

3.3 Fasilitas

Ruang Komite Medik tersedia di lantai 3C. Apabila ada rapat offline dengan kapasitas > 10, maka di fasilitasi di Hall Sakura Lantai 5



3.4 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan masih layak, sudah pernah dilakukan pengecatan ulang awal tahun 2025. Tersedia meja, kursi, lemari, dan AC.

3.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Cuti Haji : 0 orang
2. Cuti umroh : 1 orang (dr. Aida Sp. OG)
3. Cuti sekolah : 0 orang
4. Cuti karena sakit : 1 orang (dr. Iwan Sp. B)
5. Dokter resign : 0 orang

3.6 Mutu

NO	JUDUL	STD	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata/bln	Ket
1	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Standart terpenuhi
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	21,02%	23,28%	24,9%	89,1%	89,1%	80,7%	93,02%	93,07%	99,35%	97,35%	91,73%	91,73%	44,56%	Belum sesuai standart
3	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	2,97%	3,89%	1,97%	1,27%	0%	0,66%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,89%	Belum sesuai standart
4	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	64%	61,93%	67,3%	67,1%	60,12%	61,41%	62,55%	65,45%	61,17%	61,43%	58,3%	73,47%	63,68%	Belum sesuai standart
5	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	99,99%	99,99%	99,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	Belum sesuai standart
6	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	66,6 %	22,5%	85%	85,3%	62,9%	53%	91,6%	92,6%	100%	98,8%	77,65%	90,56%	77,20%	Belum sesuai standart
7	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Standart terpenuhi
8	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Standart terpenuhi
9	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	2,97%	3,89%	1,97%	1,27%	0%	0,66%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5,38%	Belum sesuai standart
10	Angka Keterlambatan dokter di Poli Rawat Jalan	0%	25,2%	23,13%	25,44%	23,98%	22,79%	23,28%	16,25%	16,67%	15,78%	18,17%	15,82%	14,73%	19,58%	Belum mencapai standart

Tabel 3.6.2 Analisis dan RTL Ketidaktercapainnya Mutu

No	Indikator Mutu	rata-rata pencapaian /bln	Analisis	Hasil TL dari RTL
1	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	100%	Standart terpenuhi	Pertahankan capaian, karena masuk mutu INM, sehingga tahun masih masuk di mutu komdik
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	44,56%	Belum sesuai standart	Waktu tunggu masih belum memenuhi standart karena angka keterlambatan dokter rata-rata per bulan 19,58%
3	Penundaan Operasi Elektif	0,89%	Belum sesuai standart	Penundaan operasi elektif terjadi karena pasien belum siap, minta reschedule jadwal, atau karena kondisi pasien yang berubah saat akan operasi. Selain itu, pada pasien phaco, pre op phaco yang tidak maksimal dan pupil sulit lebar menyebabkan reschedule jadwal op
4	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	63,68%	Belum sesuai standart	Kepatuhan visite dokter belum sesuai, karena beberapa dokter ada yang visite setelah praktek poli, dan diatas jam 16.00 wib
5	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	99,99%	Belum sesuai standart	Kepatuhan penggunaan formularium nasional mendekati standart, karena dokter patuh meresepkan sesuai billing SIMRS, dan adanya system proporsi menjadi salah satu faktor dpjp meresepkan sesuai plafon inacbg's dan ketersediaan stok obat di farmasi
6	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	77,20%	Standart terpenuhi	Kepatuhan terhadap alur klinis (CP) masih belum memenuhi standart, dibutuhkan monitoring dan Kerjasama dari Karu dan dokter ruangan untuk kontrol pasien sesuai dengan PPK – CP yang telah dibuat
7	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	Standart terpenuhi	Pertahankan capaian, masuk mutu RS tahun depan, karena menjadi



				salah satu penilaian akreditasi
8	Kejadian kesalahan input e-resep	0	Standart terpenuhi	Pertahankan capaian, masuk mutu RS tahun depan, karena menjadi salah satu penilaian akreditasi
9	Angka Ketidaklengkapan Pengkajian Awal Medis IGD	3,1%	Belum sesuai standart	Angka ketidaklengkapan pengkajian awal medis adalah yang rawat inap karena belum ERM. Untuk rawat jalan, kelengkapan 100% karena tidak bisa divalidasi jika belum lengkap
10	Angka keterlambatan poli di rawat jalan	19,58%	Belum sesuai standart	Angka keterlambatan ditindaklanjuti dengan absensi DPJP by simrs, dan surat pemberitahuan jika keterlambatan 100% lebih dari 1 x

3.7 EVALUASI JADWAL KEGIATAN KOMITE

Jadwal kegiatan Komite Medik adalah :

No	Kegiatan	Pemenuhan*
1	Rapat rutin tiap bulan	Rapat koordinasi by WA dan Zoom meeting

3.8 ANALISIS KESELURUHAN DAN SARAN

Untuk pengembangan pelayanan ada yang belum terlaksana, meskipun ada kendala di setiap prosesnya, akan dibahas dan di evaluasi melalui rapat komite medik setiap bulan. Dalam rapat tersebut, komite medik juga mengundang staf manajemen, jajaran kabid dan direktur, KMKB, maupun staf PT agar setiap rapat menghasilkan keputusan / feed back yang baik pada DPJP dan anggota komite medik RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Komite Medik Tahun 2025 ini dibuat, sebagai evaluasi untuk diketahui Kabid pelayanan dan Direktur. Semoga laporan tahunan ini dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien RS Prima Husada Malang.

Mengetahui
Ketua Komite Medik



dr. Arief Heru Wicaksono, SpAn-TI

Malang, 08 Januari 2025

Dibuat oleh,
Sekretaris Komite Medik



Fadhila Ayu Setyani, S.Kep.,Ns

Mengetahui
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes